

Traitement

Il est important d'en parler à un spécialiste : c'est l'**aide psychologique**.

Le suivi psychologique permet de mieux comprendre et accepter ce diagnostic de CPNE.

Le but du traitement est de contrôler, réduire puis stopper vos crises.

L'objectif de l'aide psychologique est de découvrir ce qui déclenche et favorise vos crises.

L'intérêt est de mieux **identifier vos émotions et gérer votre stress.**

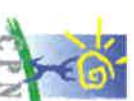
Les médicaments antiépileptiques ne sont pas efficaces.

N'oubliez pas que les personnes atteintes de CPNE sont des personnes **normales** avec des crises réelles.

Sans prise en charge psychologique vos crises risquent de perdurer.

À retenir

- Vos crises ne sont pas causées par de l'épilepsie mais elles sont réelles et ont un grand impact sur votre vie
- Le terme psychogène ne signifie pas que vous simulez ou que vous êtes fou
- Ce n'est pas votre faute
- Les crises ne causent pas de dommages au cerveau
- Accepter et comprendre le diagnostic est la première étape de la guérison
- L'aide psychologique est utile pour trouver les causes des crises et vous aider à les contrôler
- Pour que le traitement soit plus facile, il est important d'en parler à vos proches. Vous pouvez leur montrer ce livret et en discuter avec eux



CPNE

Crises psychogènes non épileptiques

Crises psychogènes non épileptiques : cela signifie que les crises ressemblent à de l'épilepsie mais qu'elles n'en sont pas.

Vos crises ne sont pas causées par des lésions cérébrales.

Elles sont d'**origine psychologique**.

Vos crises sont réelles.

Cette maladie est fréquente.

Elle est connue par les spécialistes.

Un patient sur 5 adressé à des spécialistes de l'épilepsie souffre de crises psychogènes non épileptiques (CPNE).

Les médicaments antiépileptiques ne sont pas efficaces pour vos crises psychogènes non épileptiques.

Le seul traitement efficace et reconnu est l'**aide psychologique**.

Symptômes

Lors d'une crise psychogène non épileptique vous pouvez :

- ✓ Avoir des mouvements non contrôlés
- ✓ Perdre contact avec votre environnement
- ✓ Vous évanouir/tomber à terre
- ✓ Parler/crier
- ✓ Ne pas vous souvenir de la crise

À cela peut s'ajouter :

- ✓ Maux de tête, des douleurs
- ✓ Tristesse/pleurs
- ✓ Inquiétude/panique
- ✓ Problèmes urinaires
- ✓ Problème de mémoire

Ces symptômes peuvent être confondus avec ceux d'une crise d'épilepsie.

N'oubliez pas :

Vos crises sont de vraies crises avec une origine psychogène.

Causes

Les CPNE peuvent être liées aux émotions ou au stress.

Souvent, les premières crises sont liées à un stress, à un choc émotionnel ou à des expériences douloureuses.

Au fil du temps les crises peuvent se produire au hasard et sans avertissement.

Les causes des crises ne sont pas toujours évidentes ou connues

Il se peut que vos crises soient liées à un traumatisme

Il est bien connu que le stress émotionnel peut provoquer des réactions physiques telles que : palpitations, transpiration, maux de tête ou autre...

Une manière d'être affecté par le stress et les émotions est de faire des crises psychogènes non épileptiques.

Votre cerveau "s'éteint" pendant un certain temps et vous n'avez plus le contrôle de vos actions.

Que dire à votre entourage ?

- « J'ai des crises que je ne peux pas contrôler »
- « Elles sont comme des crises d'épilepsie mais elles ne sont pas causées par les mêmes choses »
- « Je ne fais pas exprès »
- « Mes crises peuvent être liées au stress »
- « La cause de mes crises n'est pas entièrement comprise »

J'ai des crises psychogènes non épileptiques :

- ✓ Parlez-moi calmement
- ✓ Mettez-moi à l'abri des blessures
- ✓ N'essayez pas de mettre quelque chose dans ma bouche
- ✓ Mes crises ne causent pas de dommage au cerveau
- ✓ N'appellez pas d'ambulance sauf si je suis blessé ou si la crise ne s'arrête pas